

אנשים עם מוגבלות קוגניטיבית או פיגור

בטיפול באנשים עם מוגבלות קוגניטיבית חשוב לדבר גם עם ההורה או המטפל העיקרי. יש לזכור כי גם המטופלים עצמם יתקשו לפעמים להסביר לצוות הרפואי מה הבעיה.

הדברים שמקשים על לקיחת אנמנזה ואבחון הם: קשיי תקשורת עם המטופל, המטופל עצמו לא תמיד מודע לבעיה שממנה הוא סובל. יש מטופלים שנמצאים בהשפעת תרופות, והמוגבלות שלהם מתבטאת בתגובה דלה לגירויי הסביבה.

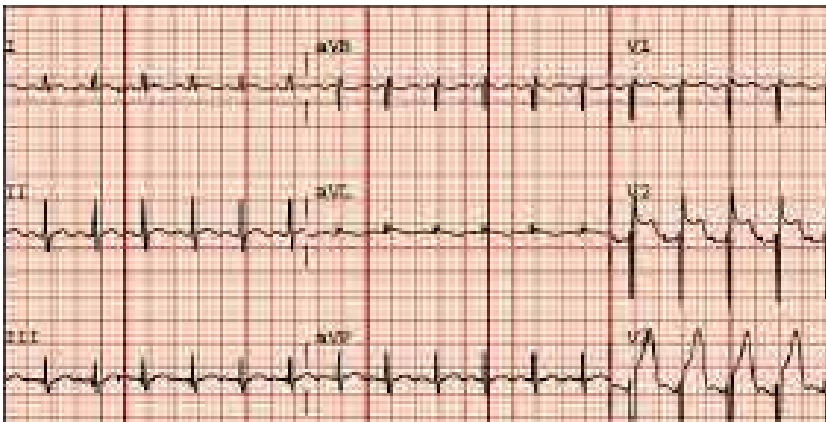
לכן חשוב לתשאל את המלווה - ההורה או המטפל העיקרי, ולהשוות למצב הבסיס כדי שלא להגיע לאבחון שגוי ובעקבותיו לתת טיפול שגוי.

בנוגע לטיפול ולפינוי חשוב לברר אם המטופל עבר ניתוח, אם יש שתל זר בגופו, וכן חשוב לבדוק מה צורת התקשורת המתאימה וכיצד הכי טוב לטפל בשתל כדי למנוע החמרה וכן כדי לבדוק שהמצב הרפואי אינו קשור אל השתל.

פגועי נפש, מתמודדי נפש

טיפול חירום בפגועי הנפש ומתמודדי נפש מעמיד בפני המטופלים אתגרים מכמה כיוונים. ראשית, שיתוף הפעולה יכול להיות מוגבל או כלל לא קיים. לעיתים המטפל עלול להיתקל בתגובה אלימה עד כדי סיכון הצוות המטפל, ולעיתים יש צורך להזעיק כוחות ביטחון.

שנית, אף אם שיתוף הפעולה משביע רצון, יש להביא בחשבון שבוחן המציאות של המטופל יכול להיפגע, ולכן ייתכן שהמטופל ימציא בעיות או ביטויים קליניים שאינם פעילים או למסך בעיות פעילות. המטופל יכול לנסות להסיט את השיחה לדיון בנושאים שאינם רלוונטיים. נוסף על כך, יש לזכור שמנעד תופעות הלוואי של התרופות הפסיכיאטריות הוא רחב ביותר ויכול להתבטא בהפרעות נפשיות, אריתמיות, בעיות מוטוריות, שינויים אלקטרוליטיים או בספירת הדם, בפריחות בעור והפרעות באוטונומיות (תרשים 18.4). תרופות אלו עשויות להתנגש עם התרופות שניתנות בטיפול השגרה ברמת השטח.



תרשים 18.4 הפרעת קצב כתופעת לוואי של תרופות פסיכיאטריות

בתמונה מופיעה דוגמה של אק"ג של מטופל צעיר הנוטל תרופה פסיכיאטרית מסוג Clozapine. באק"ג רואים LVH Anterior ST elevation, כינוס טכיקרדיה.

קווי יסוד לאבחון, תשאול וטיפול

הבעיה הדחופה יכולה להיות מצב חירום פסיכיאטרי, מצב חירום רגיל או בעיה משולבת. קשיים אלו ועוד רבים אחרים הם האתגרים העומדים בפני המטפל באדם פגוע נפש או מתמודד נפש. אין פתרון אחד לכל הבעיות ולא תמיד אפשר למצוא מענה אופטימלי לטיפול הנדרש, אך יש כמה קווי בסיס לגישה הטיפולית שיכולים לסייע.

- לא להסס לשאול על הרקע הנפשי, על טיפול תרופתי קבוע, על היענות לטיפול, על שימוש יתר בתרופות ושימוש מקביל בסמים או באלכוהול.
- על המטפל להציג את עצמו ולבקש רשות טרם בדיקה גופנית או פרוצדורה, בייחוד אם המטופל נראה מפוחד. גישה זו יכולה לעזור ליצור קרבה ואמון במהלך הטיפול ולהפיג חששות הדדיים.
- למעט מקרה שבו הקריאה הזמנה על ידי קרוב של פגוע הנפש, ההתייחסות צריכה להיות כאל כל מטופל אחר.
- אם המטופל מתנהג באגרסיביות, אין להיכנס לעימות. יש להתרחק ולפעול על פי הנהלים תוך אבטחת המקום.
- אופי התקשורת עם המטופל הוא אינדיבידואלי וצריך להיות מותאם לו אישית. בחלק מהמקרים יהיה צורך לדבר עם המטופל בטון חם וקרוב לעומת אחרים שאיתם יידרשו אסרטיביות ותקיפות.
- יש להיות עם סף חשד נמוך לאפשרות של מקרה אובדנות ולהיעזר במלווים ובסקירת סביבת המטופל עבור רמזים לכך.

הטיפול במצבי חירום ברפואת הנפש

הפרק הזה יעסוק במצבים דחופים ברפואת הנפש הדורשים את ההתייחסות המיידית של הצוות הרפואי בשל סיכון לחיי הפרט או לסביבתו:

- (1) אובדנות (suicidity)
- (2) אלימות
- (3) אי־שקט קיצוני על רקע מצב נפשי לא מאוזן (מחלת נפש קיימת או שימוש בסמים)
- (4) התקף חרדה (panic attack)
- (5) הפרעת דחק חריפה (ASD)

(1) אובדנות (Suicidality)

מצב החירום העיקרי שבו מטפלים הפסיכיאטרים הוא הטיפול באדם עם נטיות אובדניות פעילות מוכחות. התאבדותות הן כ־1% מכלל מקרי המוות של בני 15 ומעלה. מבחינים בין התאבדות שמומשה ובין ניסיון התאבדות. ההבדלים בין ניסיון התאבדות ובין התאבדות בא לידי ביטוי הן בהיבטים הדמוגרפיים, הן במצב המשפחתי והן בעונות השנה. רוב המתאבדים סובלים ממחלת נפש רצינית, בעיקר דיכאון קשה, וכרבע מהם משתמשים בסמים ובאלכוהול. המנסים להתאבד בדרך כלל אינם סובלים ממחלת נפש אלא ממשברים בחייהם האישיים, וניסיון התאבדות זה הוא לרוב קריאה לעזרה.

ההבדל בין התאבדות לניסיון התאבדות

להלן כמה מן ההבדלים בין התאבדות ובין ניסיון התאבדות:

שכיחות

- שיעור המתאבדים הוא 5-7 איש לכל 100 אלף. היחס בין גברים לנשים הוא 3 (נשים): 4 (גברים).
- שיעור ניסיונות התאבדות גדול כמעט פי 10, והיחס בין גברים לנשים הוא במגמה הפוכה 1.5 (נשים): 1 (גברים).
- נמצא כי שיעור האובדנות בקרב עולים חדשים מרוסיה או מאתיופיה גבוהים בצורה ניכרת לעומת ילידי הארץ.

אמצעים

- אצל גברים דרך ביצוע ההתאבדות השכיח ביותר בכל קבוצות הגיל הוא תלייה או חנק ואחר כך נשק לסוגיו.
- אצל נשים ניסיונות ההתאבדות השכיחים מבוצעים על ידי בליעה של כדורים או חומרים רעילים.

הערכת הסיכון האובדני

הערכה מלאה של מצב המטופל לאחר ניסיון אובדני תתאפשר רק לאחר השלמת שיחה עם פסיכיאטר. המטרה היא לקבוע את הסיכון האובדני וכן לקבוע אם המטופל סובל ממחלת נפש כלשהי.

בתשאל יש להעריך כמה היבטים:

- 1) שלילת סכנה מיידית - מעריכים ביסודיות את האמצעי ובייחוד את הסם, התרופה, הרעל שנצרך וכמותו. לפי זה מעריכים את מידת הניטור הנדרשת ואת אמצעי הפינוי העומדים לרשותנו.
- 2) גורמי רקע - מבררים אם היו ניסיונות קודמים ומה היה הטריגר לניסיון ההתאבדות הנוכחי. ככל האפשר מנסים להבין את הקשיים שעומדים מאחורי האדם, הקשיים העומדים ברקע ההתאבדות.
- 3) הכוונה האמיתית של ניסיון ההתאבדות - יש לבחון את האמצעי, לברר אם האדם דאג שמישהו ידע על הניסיון, אם כתב מכתב התאבדות.
- 4) סיכון עתידי - מבררים אם האדם מביע חרטה, אם מדבריו עולה כי יש לו רצון אמיתי למות וחשוב לברר נגישות לאמצעים מסוכנים דוגמת נשק.

טיפול

הטיפול מחייב מעורבות של פסיכיאטר; מדרג הטיפול הפסיכיאטרי בהמשך בנוי כך:

- 1) אשפוז כפוי - ייעשה רק באישור פסיכיאטר מחוזי ואם מתקיימים התנאים לכך על פי הוראות החוק (ראו להלן).
- 2) המלצה לאשפוז מרצון - הפסיכיאטר ימליץ על כך בסיכון אובדני גבוה ולפי ההתרשמות הפסיכיאטר ממחצבו הנפשי של המטופל. למשל אם יש מחלת נפש, אם יש צורך בטיפול

תרופתי פעיל או אם יש סביבה תומכת מחוץ לבית החולים.

(3) המלצה לטיפול מרפאתי - הפסיכיאטר ימליץ על כך במקרים של סיכון נמוך ואז אפשר לשחרר את המטופל ולהמליץ על המשך ייעוץ ותמיכה נפשית במסגרת האמבולטורית המתאימה.

(2) אלימות

אנשים עם הפרעות נפשיות מעורבים לעיתים במעשי אלימות, אולם הקשר בין אלימות להפרעות נפשיות מורכב ושונה ממה שהציבור בדרך כלל מאמין בו. הסטטיסטיקה על פשעים אלימים מראה שאנשים עם הפרעות נפשיות הם רק אחוז מזערי מכלל עברייני האלימות. יתרה מזאת, אנשים עם תחלואה נפשית נוטים לפגוע בעצמם יותר משיפגעו באנשים אחרים, והם נמצאים בסיכון גבוה יותר ליפול קורבן לאלימות בעצמם, בהשוואה לאוכלוסייה הבריאה. למעשה, 96% ממקרי האלימות בחברה מקורם באוכלוסייה הכללית דווקא ולא באוכלוסיית מתמודדי הנפש, היות שרק 4% מהאלימות בחברה מיוחסת לאנשים עם מחלת נפש. אומנם לאדם במצב פסיכוכי סוער או למי שאובחן בהפרעת אישיות אנטי־סוציאלית, יש הסתברות סטטיסטית גבוהה יותר להיות אלים יחסית לאדם בריא, אבל רוב האלימות הזאת באה לידי ביטוי בתחילת האשפוז הפסיכיאטרי או בין כותלי בית הכלא.

גורם חשוב בניבוי אלימות - בין באוכלוסייה הכללית ובין בקרב נפגעי נפש - הוא השימוש באלכוהול או בסמים. שימוש בחומרים משני תודעה הוא גורם קריטי בליבוי אלימות בכלל ובליבוי אלימות בקרב מתמודדי נפש בפרט. לסיכום, בעיות נפשיות לבדן אינן מנבאות התנהגות אלימה. אי לכך יש להיזהר מסטיגמטיזציה גורפת של ציבור נפגעי הנפש.

(3) אי־שקט קיצוני על רקע מצב נפשי לא מאוזן

יכול להופיע על רקע מחלת נפש קיימת או שימוש בסמים.

(4) התקף חרדה (Panic Attack)

התקף חרדה הוא התקף פתאומי וקצר הנמשך בדרך כלל דקות ספורות עד שעה, ובדרך כלל מתואר על ידי המטופל כתחושת פחד מוות שהציפה אותו. הסימנים יכולים להיות דומים לאלו של התקף לב או של מצבים דחופים אחרים. התופעה אינה נדירה, כ־2% מהאוכלוסייה סובלים מהתקפים חוזרים ושיעור האנשים שעברו בחייהם התקף יחיד גבוה הרבה יותר. התופעה שכיחה יותר בנשים ומופיעה פי 4.5 יותר בחולי אסתמה. ההתקף אינו מסכן את חיי האדם אולם גורם לסבל קשה.

סימנים

דפיקות לב, הזעה, נשימה מהירה, תחושת חנק, כאבים או אי־נוחות בחזה, סחרחורות, בחילות, צמרמורות וגלי חום. לעיתים האדם מתאר תחושה של התנתקות מהמציאות או תחושה ש"אני משתגע".

טיפול

הטיפול מתחלק לשניים: טיפול תומך וטיפול תרופתי.

- (1) טיפול תומך - הרגעת המטופל ואם ההקשר נכון ומאפשר זאת אפשר לשלב מגע פיזי עדין כגון ליטוף. נוכחות בני אדם קרובים למטופל ושהייה בסביבה מוכרת הן חשובות במסגרת ההתאוששות מהתקף החרדה החרף. לאחר היציאה מההתקף מומלץ להציע הסבר על מהות התופעה ולברר את הרקע: התקף חרדה יכול לקרות למשל בעקבות בשורה מרה על אובדן אדם יקר, פיטורים, בחינות וכדומה. לפי מהלך התקף החרדה ובהתאמה לאופי המטופל, מומלץ להציע אפשרות לפנות לקבלת עזרה נפשית.
- (2) טיפול תרופתי - הטיפול העיקרי מבוסס על נוגדי חרדה מקבוצת הבנזודיאזפינים (דוגמת ואליום, דורמיקום וקלונקס).

(5) הפרעת דחק חריפה (Acute Stress Disorder: ASD)

הפרעת דחק חריפה היא מצוקה נפשית חריפה, הנמשכת ארבעה ימים עד חודש, באנשים שחוו אירוע נפשי קשה או אירוע קשה גופנית ונפשית גם יחד, למשל מעורבות בפיגוע או בתאונת דרכים. התערבות מוקדמת מפחיתה סיכון לתופעות עתידיות ובייחוד הפרעת דחק פוסט־טראומטית (PTSD, הלָמֶת).

טיפול

הגישה הטיפולית בנויה משני מרכיבים חשובים: סמיכות לאירוע ובניית ציפיות. הסמיכות לאירוע - ככל שההתערבות ניתנת בשלב מוקדם יותר ובסמיכות למקום האירוע, כך סיכויי הצלחת הטיפול גדלים. מרכיב שני הוא בניית ציפייה. במקביל להרגעת המטופל וחיזוקו, יש לאפשר ואף ליזום חזרה לתפקוד סדיר ושוטף מוקדם ככל האפשר. למעשה, המפתח העיקרי לטיפול הוא חזרה מהירה לשגרת חיים מלאה. לדוגמה החזרת נהג אוטובוס לנהוג באותו קו יום למחרת מעורבותו בפיגוע.

(6) תסמונת פוסט־טראומטית, תסמונת בת־חבלתית (Post-Traumatic Stress Disorder: PTSD)

תסמונת פוסט־טראומטית (PTSD) היא הפרעת חרדה כרונית קשה שמתפתחת אחרי אירוע קטסטרופלי שהאדם עבר בדרך כלל בעקבות או בקשר למצבים אלו: הלם קרב, אונס, התעללות, תאונות דרכים ופיגועים. אדם שסובל מההפרעה כמו חי מחדש את האירוע וסובל מזיכרונות חוזרים של האירוע עצמו, יש לו חלומות טורדניים, פלשבקים (הבזקים של העבר) או עוררות פיזיולוגית כגון: התקפי רעד, הזעה, טיקרדיה. כמו כן מתפתחת אצלו התנהגות הימנעותית שנועדה לצמצם מגע עם כל גורם שעשוי לעורר את הזיכרון. ההפרעה קשה לטיפול וגורמת למטופלים סבל רב, ולכן המניעה שלה חשובה מאוד. תפקידו העיקרי של החובש הוא להרגיע ככל האפשר את המטופל ולבצע את הוראות הפסיכיאטר.

אשפוז פסיכיאטרי מרצון ואשפוז כפוי

אשפוז מרצון - הוא אשפוז בהסכמת המטופל או לבקשתו. מתמודד נפשי רשאי לפנות לבית חולים בבקשה להתאשפז מרצונו. הוא יאושפז רק לאחר שנבדק ונמצאה הצדקה לאשפוזו. הוא גם ישתחרר מרצונו, אלא אם כן הפסיכיאטר המחוזי החליט על אשפוז בכפייה.

אשפוז בכפייה - לפסיכיאטר המחוזי סמכות להורות על אשפוז בכפייה של נכה נפש, אם הוא עונה על התנאים הקבועים בחוק טיפול בחולי נפש (התשנ"א-1991). אשפוז בהנחיית פסיכיאטר מחוזי יארך לכל היותר שבעה ימים והוא רשאי להאריך את האשפוז בשבוע נוסף. לאחר מכן יש סמכות לוועדה הפסיכיאטרית המחוזית להאריך את האשפוז לתקופות נוספות. במקרים מסוימים רשאי מנהל בית החולים להורות על אשפוז בכפייה גם ללא הוראת אשפוז מפסיכיאטר מחוזי, וזאת למשך 48 שעות בלבד. במקרים מסוימים אפשר להורות על אשפוז בכפייה של קטינים.

מסגרות האשפוז בתחום בריאות הנפש הן מגוונות ובאופן מסורתי מחולקות לשני סוגי מחלקות:

- (1) מחלקות פתוחות - המטופל מאושפז מרצונו החופשי ודלתות המחלקה אינן נעולות בפניו. המחלקה משלבת עבודה פעילה שוטפת מחוץ לכותלי בית החולים הפסיכיאטרי.
 - (2) מחלקות סגורות - אין למטופל זכות לצאת מן המחלקה. אלו מאושפזים בכפייה או מאושפזים מרצון הנמצאים בהתקף קשה במיוחד.
- אשפוזים בכפייה מוסדרים בחוק ומחייבים בדיקה מקדימה והוראה בלעדית של הפסיכיאטר המחוזי. לפי החוק יש קריטריונים הכרחיים עבור יישום האשפוז:

- (1) המטופל מסרב לבדיקת פסיכיאטר.
- (2) בעקבות ההפרעה הנפשית יש פגיעה חמורה בבוחן המציאות או בכושר השיפוט של המטופל.
- (3) המטופל עלול לסכן פיזית את עצמו או את זולתו באופן מיידי.

אנשים מקבוצות דתיות ועדתיות

בני מיעוטים בכפר

שלא כמו הטיפול בבני מיעוטים שגרים בעיר, שאינו שונה מהותית מאוכלוסייה אחרת בעיר, יש לעיתים כפרים של בני מיעוטים שבהם נשמרת מסגרת קהילתית דתית או שמרנית אורתודוקסית. לכן חשוב להיות ערים לאופי הקהילה ולהביא בחשבון כמה מאפיינים שימנעו שגיאות ויעזרו לתת את הטיפול המיטבי.

(א) זמן הגעה

כפרים רבים יושבים לעיתים באזורים הרריים או מרוחקים, לכן זמן ההגעה אל המטופל עלול להיות ארוך מהרגיל. בשל מבנה הכפר, היעדר שילוט ברור, היעדר שילוט בעברית, היעדר מספרים על הבתים, בדרך כלל קשה לאתר את הכתובת המדויקת, ולכן אף מכשירי הניווט בדרך כלל אינם עוזרים. כדאי להיעזר באנשי

המקום, אם כי יש להביא בחשבון שעבור מי שאינו מכיר את הכפר ההסבר עלול להיות מבלבל ויעבור פרק זמן מכריע וקריטי לטיפול. בעיה נוספת היא שלא תמיד התשתיות מטופלות כראוי, ולכן דרכי ההגעה, איכות הכבישים, סמטאות צרות וכבישים הרריים מפותלים פוגמים באפשרות לפנות את המטופל במהירות. כמו כן קיימת סכנה לתאונות דרכים.

(ב) סגנון ואורח חיים

סגנון החיים בכפרים מאופיין בקהילתיות, מגורים משותפים או סמוכים של קרובי משפחה רבים ושיתוף בחיי היום יום ובייחוד בעת מקרה חירום רפואי. לכן, לעיתים אם הצוות הרפואי מתעכב בגלל המגבלות הגאוגרפיות שצוינו כאן, הוא עלול להתקבל בכעס של בני המשפחה המורחבת, ואל הטיפול עלולה להתלוות אווירת מתח ולחץ שיכולה להשפיע על הצוות המטפל ולהגביל את הטיפול. הקושי להעניק טיפול מתגבר בגלל הנטייה של בני משפחה שמלווים את הטיפול ומתקהלים מסביב.

לעיתים הצוות הרפואי נקרא לטפל בנפגעים עקב אירוע טראומה במרחב הציבורי דוגמת קטטה או תאונת דרכים. גם כאן עלולה להיות התקהלות של אנשים מתוחים ונסערים, הקטטות התוך־קהילתיות עלולות לשוב ולהתלקח, ואווירת המתיחות יכולה להצית סכסוכים קיימים או להוביל להתלקחות בין קבוצות יריבות. מצבים כאלה מסכנים לעיתים קרובות את הצוות המטפל מעצם היותו במקום או משום שהוא נתפס כמסייע לאחד הצדדים.

(ג) פערי שפה

אף על פי שעריי ישראל לומדים עברית בבית הספר, רמת ידיעת השפה אינה אחידה. משום כך האנמנזה יכולה להיות מוגבלת בשל שפת גוף שונה או פערי שפה. בעיה נוספת בתקשורת יכולה להיווצר גם בשל פרשנות שונה לתלונות גופניות הנובעת מהבדלי תרבות.

הגישה המומלצת

זמן הגעה - מניסיון העבר עולה כי מומלץ לבקש טלפונית שכלי רכב ימתין בכניסה לכפר כדי שיוכל להוביל את הצוות הרפואי עד לבית המטופל או לאתר הטראומה.

סגנון ואורח חיים - בשום מצב אין להיגרר לריב עם המשפחה גם אם נשמעות הטחת טענות והשמצות. על אנשי הצוות לענות בסבלנות ובאדיבות. מומלץ להפנות את כל תשומת הלב למטופל או לנפגעים ומייד להשלים אנמנזה בסיסית בד בבד עם התחלת פינוי מוקדם לאמבולנס, שם אפשר להשלים את אנמנזה. באירועים עם פוטנציאל התלקחות אפשר לערב את כוחות הביטחון, והדבר נתון לשיקול הדעת של הצוות המטפל.

פערי שפה - לגבי מכשול השפה. אפשר לקחת מסמכים רפואיים קודמים ומתוכם להתעדכן על הרקע הרפואי. אם אין מוצא אחר, אפשר להשתמש במלווים או עוברי אורח לצורך תרגום, אך יש לבקש את רשות המטופל טרם שמכניסים מתווך לדו־שיח.

יהודים חרדים ואולטרה־אורתודוקסים

ככלל - בכל אוכלוסייה דתית נוסף על הדגשים הסטנדרטים באבחון ובטיפול, יש כמה הנחיות שאותן חשוב להכיר ולהעניק להן תשומת לב מיוחדת כשמטפלים באנשי קהילה דתית, חרדית ואורתודוקסית.

(א) צניעות

הצניעות היא אלמנט חשוב בקרב האוכלוסייה הדתית. הנשים בקהילה מקפידות על כיסוי ראש ולבוש ארוך המותיר רק אזורי גוף מעטים חשופים. בשל כך, את שלב חשיפת המטופל (E) מבצעים ברגישות ונמנעים מאי־נחות ומפגיעה ברגשות העלולים לעורר מתיחות וכעסים מיותרים. במקרים של פרוצדורות מצילות חיים או עצירת דם אפשר לחרוג מכך על פי הכלל שפיקוח נפש דוחה את כל המצוות. וכמו תמיד, חשוב להפעיל היגיון בריא.

(ב) שמירת נגיעה

אחת המצוות החשובות בדת היא ההימנעות ממגע גופני עם בן המין השני - מצוות שמירת נגיעה. אם לא מדובר במצב חירום או טיפול דחוף, יש להשתדל כלל האפשר להתחשב בבקשתם.

הגישה המומלצת

כאשר באים לטפל באוכלוסייה דתית יש לברר לפני הטיפול אם הטיפול מפריע או פוגע ברגשות. במידת האפשר, לקחת המדדים, בדיקה גופנית והפשטה תיעשינה על ידי איש צוות בן אותו מגדר. יש להקפיד ביתר שאת על כיסוי המטופל, כולל בזמן ההעברות. מודעות לנושא והקדשת התייחסות יכולה לסייע למטופל, למנוע מבוכה ומתיחות מיותרות.

הטיפול בנפטרים

מוות הוא חלק ממגוון המצבים הרפואיים שאותם פוגשים אנשי הצוות הרפואי. לאחר קביעת מוות והכנת תעודת הפטירה על ידי רופא או פראמדיק (לפי ההנחיות משרד הבריאות), על המטפל הבכיר בשטח להסביר למשפחת הנפטר את התהליך הצפוי, כמפורט כאן.

- על המשפחה להצטייד בתעודת פטירה (בשלושה העתקים) שהוכנה על ידי הסמכות הרפואית שקבעה את המוות. אם מדובר על מוות בנסיבות לא טבעיות, כגון תאונת דרכים, התאבדות, רצח, הריגה וכדומה, על בני המשפחה להצטייד גם באישור משטרה.
- על פי החוק במדינת ישראל, חובה להזמין משטרה לקביעת מוות מחוץ לכותלי מתקן רפואי אם מדובר על מוות בנסיבות לא טבעיות.
- אם משטרת ישראל הגיעה למסקנה שאין חשד לפלילים הם מתירים למשפחה לטפל בגופה ולהכינה לקבורה.
- אם יש חשד לפלילים, הגופה תועבר לנתיחה לאחר המוות במתקן לרפואה משפטית באבו כביר. למשפחה מותר להתנגד לניתוח שלאחר המוות, ולראש לשכת חקירות מרחבי יש סמכות לוותר על המשך החקירה.

- לצורך קבלת רישיון קבורה יש לפנות למשרד הבריאות. לשם יש לבוא עם תעודת זהות של הנפטר, שלושה העתקים של תעודת הפטירה ואם מדובר על מוות בנסיבות לא טבעיות, יש להביא גם את אישור המשטרה לקבורה.
- המשפחה פונה לגוף האחראי לקבורה - יהודים פונים ל"חברה קדישא" נוצרים, ערבים, דרוזים ובני דתות אחרות פונים לגורם הדתי האחראי מטעמם, ומתאמים מועד ומקום לקבורה.
- חשוב לתאם מועד ומקום קבורה מוקדם ככל האפשר.
- כל תושב ישראל שנקבר בארץ זכאי לקבורה (באזור מגוריו) ללא תשלום.
- לאחר שיש רישיון קבורה, הגופה תועבר לחדר קירור עד למועד הקבורה.

לסיכום

צוותי מד"א על כל רובדיהם נתקלים מדי יום במטופלים ונפגעים שנמצאים ברגע של חולשה בחייהם, מלווים בתחושות פיזיות קשות (כאב) ובתחושות רגשיות קשות (פחד, חוסר אונים). הם פונים בבקשת עזרה לצוות רפואי זר שאותו לא פגשו מימיהם. הצוות הרפואי, נוסף על מקצועיותו, צריך להיות קשוב לצרכים או לבעיות של האדם הזקוק לטיפול, ולהתייחס אליו בכבוד ראש מקצועי ואישי. חובתו להבין שגם אם בעיניו מדובר בעניין קל, מבחינת המטופל מדובר על מצב חשוב ומשמעותי בחייו.

כחלק מהמקצועיות של הצוות, מצופה מהם גם להכיר את המגוון הרב של האנשים שהוא צפוי לפגוש, על ההבדלים ביניהם בתפיסות העולם שלהם ועל מגבלותיהם וקשייהם. בשל כך, חשוב שראש הצוות המטפל יתאים את עצמו למטופל, ישתף את המטופל ואת משפחתו בתהליך הטיפול, יידע את המטופל ומלוויו בכל צעד, ישאל את המטופל לגבי העדפותיו ורצונותיו, במידת האפשר יבקש הסכמה טרם הבדיקה ובנקודות הטיפול והפינוי המרכזיות.

בנושאים שנידונו בפרק זה הובאו קומץ דוגמאות של קבוצות אנשים עם מאפיינים ייחודיים וצורף הסבר בנוגע לגישה המומלצת - אישית וטיפולית. הצגנו רק דוגמאות שונות קווים מנחים כלליים, ובסופו של דבר כל מטופל שונה מחברו וכל אדם הוא לא רק חלק מקבוצה אלא גם פרט יחיד העומד לעצמו. בשל כך, אין תחליף להיגיון הישר ולשיתוף המטופל. אם המטפל קונה לעצמו גישה טיפולית נכונה הוא יוכל להתמודד עם כל האתגרים ועם כל ההבדלים בהצלחה ובכבוד וידע להימנע ממצבי מתיחות ומיחס מזלזל ששניהם מיותרים לאדם במקצוע הרפואה.

חשוב לזכור שבבסיס הדברים האמורים כאן מד"א הוא נתן שירות כמו נתני שירות אחרים במשק. ואף שמד"א מביא עימו ערך מוסף אדיר של הצלת חיי אדם שהוא ערך עליון, אין זה פוטר את המטפלים, ואולי אף מחייב יותר, להגיש טיפול מסור, אכפתי ומכבד. רמתו האישית של הצוות ויכולתו האנושית להכיר את הקשת הרחבה של בני האדם בחברה על מאפייניהם ועל ההבדלים ביניהם יהפוך את הטיפול הקונבנציונלי החשוב לטיפול הזכור לטובה.